

INSUFFISANCE AORTIQUE

Pr RABEARIVONY Nirina

Introduction

- **Définition:**
 - défaut d'étanchéité des valves sigmoïdes aortiques avec reflux diastolique de sang de l'AO vers le VG

I) Physiopathologie

- importance de la fuite liée à:
taille de l'orifice régurgitant, durée de la diastole,
gradient de P° VG - AO
- Régurgitation → surcharge de volume VG
→ dilatation VG progressive
→ contrainte pariétale → hypertrophie VG
→ compliance VG ++ → P° de remplissage N
→ IA chroniques peuvent rester
asymptomatiques pendant décennies
- À la longue → fibrose → ↘ compliance → ↘ fonction VG
→ symptômes

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.11- Circonstances de découverte:

- fortuite en cas d'IA chronique (souffle entendu lors d'une visite de médecine du travail ou d'une consultation pour une autre raison...)
- signes d'appel (dyspnée, angor,.....)
- par une complication (endocardite infectieuse,...)
- tardive, au stade d'insuffisance cardiaque

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.12- Clinique

II.121- Signes fonctionnels:

- longue phase asymptomatique
- pas de corrélation entre fuite et SF
- tardivement:
 - dyspnée (tout les stades)
 - angor (d'effort, de repos)
 - syncopes (rares)
 - lipothymie (plus fréquentes)
 - palpitations (d'effort, de repos)

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.12- Clinique

II.122- Signes physiques

a) palpation:

- choc de pointe vigoureux, étalé, dévié en bas et à gauche
(« choc en dôme de Bard »)

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.12- Clinique

II.122- Signes physiques

b) auscultation:

- **souffle diastolique** de régurgitation

- bord gauche du sternum
- holodiastolique
- doux, humé, aspiratif
- intensité variable, souvent faible
(mieux entendu en expiration forcée, thorax penché en AV, debout ou assise)

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.12- Clinique

II.122- Signes physiques

b) auscultation (suite):

- régurgitation importante:

- signes associés, inconstants

- souffle systolique d'accompagnement
(2^e EIC Droit)

- roulement présystolique de Flint
(apex)

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.12- Clinique

II.122- Signes physiques

c) signes périphériques artériels:

- importance proportionnelle au volume de régurgitation

~ ↘ PAD avec **élargissement de la PA différentielle**
(régurgitation +++ si PAD < 50 mmHg)

~ hyperpulsatilité artérielle:

- « **pouls de Corrigan** » : pouls radial ample, bondissant
- « **Signe de Musset** » : hochements de la tête rythmés par les battements cardiaques

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.13- ECG

- longtemps normal et sinusal
- HVG
- Troubles de la conduction:
 - intraventriculaire (Big, BBG)
 - auriculo-ventriculaire (BAV1 = lésion de jet)
- Troubles du rythme:
 - ESV (= dysfonction VG importante)

II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.14- Radiologie

- dilatation du VG (↗ RCT)
- dilatation AO ascendante (débord arc sup. droit)
- OG, VD normaux (sauf IA évoluée, dysfonction VG)

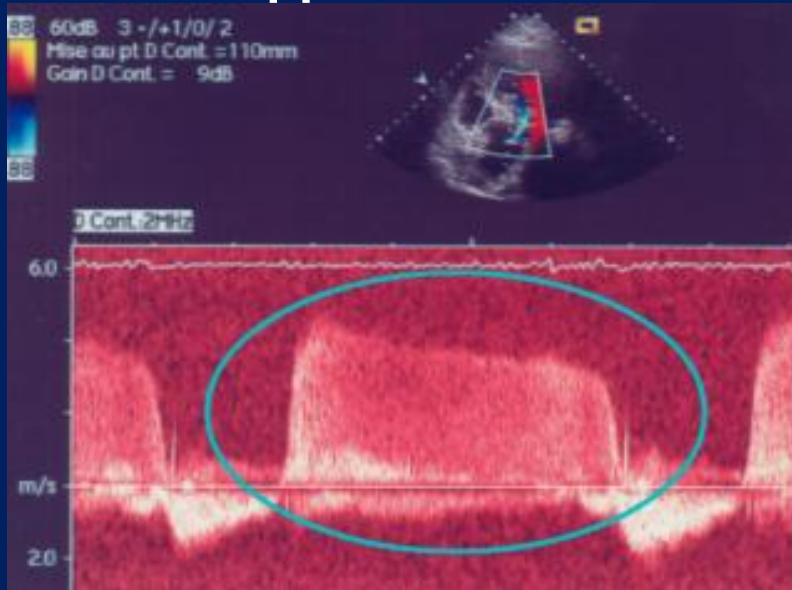
II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

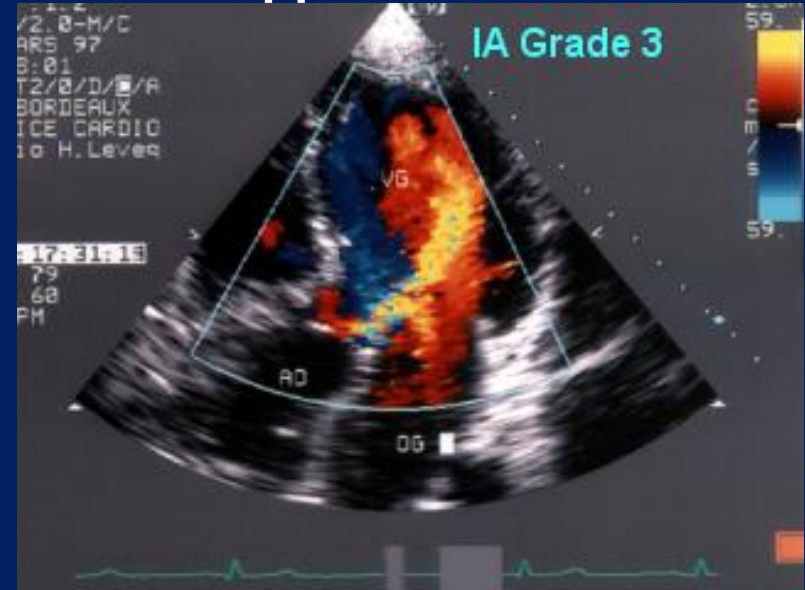
II.15- Echodoppler cardiaque

- affirme la fuite AO

Doppler continu



Doppler couleur

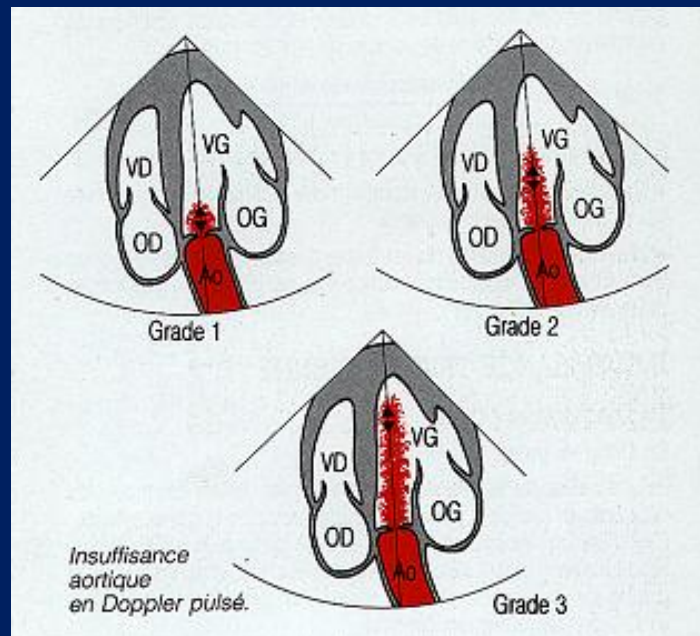


II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.15- Echodoppler cardiaque

- précise l'aspect des valves
- recherche les lésions associées (mitrale,...)
- quantifie l'IA :

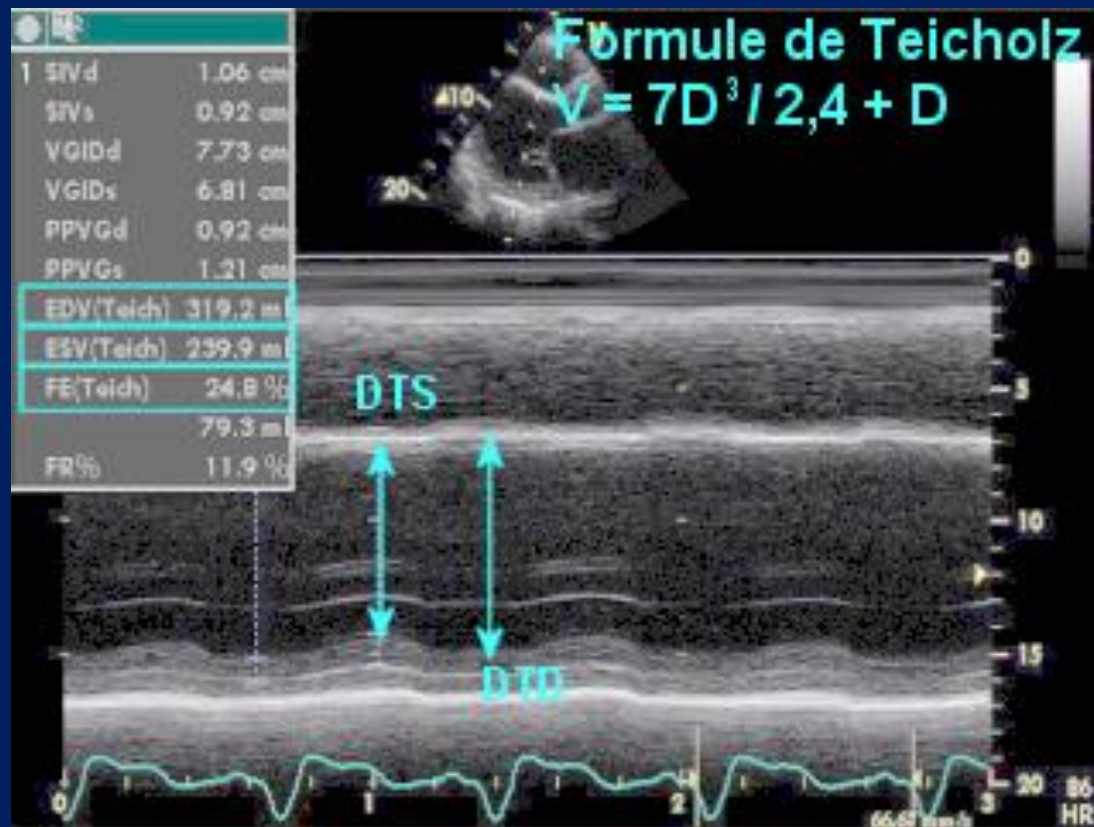


II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.15- Echodoppler cardiaque

- apprécie le retentissement de l'IA sur la fonction VG



II) Signes

II.1) Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

II.16- Evolution spontanée

- la majorité des IA restent longtemps bien tolérées (pauci ou asymptomatique)
- le diamètre VG augmente progressivement
- la dysfonction VG s'installe tardivement

II.17- Complications

- endocardite infectieuse +++
- mort subite (rare) ; à craindre si ESV +++

II) Signes

II.2) Formes cliniques

II.21- Formes évolutives

II.211- IA chronique (Type de description)

II.212- IA aiguë

- causes: endocardite infectieuse, dissection AO, traumatisme thoracique
- tableau clinique bruyant et d'installation rapide (dyspnée, OAP, angor, choc cardiogénique)

II) Signes

II.2) Formes cliniques

II.22- Formes associées

- IA + atteinte mitrale
- IA + atteinte tricuspide

III) Diagnostic

III.1) Positif:

- posé par la clinique (Souffle diastolique)
- confirmé par l'échodoppler

III.2) Différentiel:

III.21- souffle diastolique:

- Insuffisance pulmonaire

III.22- Double souffle:

- rupture d'un sinus de Vasalva

III.23- Souffle continu:

- PCA, fistule coronaire

III) Diagnostic

III.3) Etiologique

III.31- IA avec atteinte valvulaire

- dysplasie valvulaire AO (pays développés.)
- RAA (pays sous-développés)
- Endocardite infectieuse
- bicuspidie (congénitale)
- aortites infectieuse ou inflammatoire:
 - spondylarthrite ankylosante
 - polyarthrite rhumatoïde
 - LED
 - syphilis

III) Diagnostic

III.3) Etiologique

III.32- IA sans atteinte valvulaire

III.321- dystrophies de l'AO ascendante:

- dystrophie isolée
- mdies du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos)
- mdie annulo-ectasiente (+ dilat° anneau)

III.322- Dissection de l'AO

Types I et II de De Bakey
(atteinte de l'AO ascendante)

IV) Traitement

IV.1- Moyens

IV.11- Médical

- IEC
- diurétiques
- anti-arythmiques
- β -bloquants
- Antibiotiques

IV. 12- Chirurgical

IV.121- Remplacement valvulaire sous CEC

- bioprothèse
- Prothèse mécanique (AVK à vie)

IV) Traitement

IV.1- Moyens

IV. 12- Chirurgical

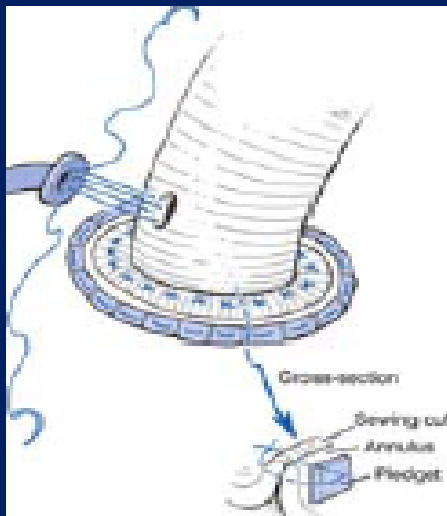
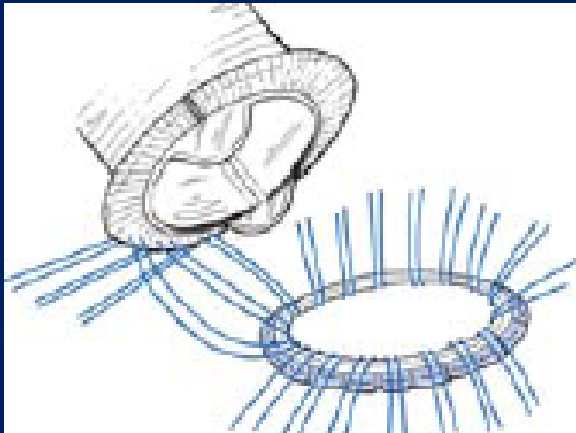
**IV.122- Remplacement valvulaire + prothèse AO
ascendante + réimplantation des
coronaires**

- Opération de BENTALL

IV.123- Plastie AO + prothèse AO ascendante

-Opération de YACOUB

TRAITEMENT



Opération de BENTALL

IV) Traitement

IV.2- Indications

IV.21- Médical

- Prophylaxie de l'endocardite infectieuse+++
(même IA minime)**
- Les IEC donnés précocement empêcheraient
la dysfonction VG → retarde l'indication
chirurgicale**
- Diurétiques dans IA symptomatiques**

IV) Traitement

IV.2- Indications

IV.21- ChirurgicaI:

IV.211- IA symptomatiques (dysfonction VG)

- indication formelle

IV.212- IA pauci ou asymptomatiques

- chirurgie quand:

- DTSVG $\geq$ 50 mm (echo)

- RCT $\geq$ 0,60 (radio)

IV.213- IA + dissection AO proximale

- indication en urgence (BENTAAL)

IV) Traitement

IV.2- Indications

IV.21- Chirurgical:

IV.214- IA sévère avec dilatation AO ascendante

- chirurgie recommandée

(indépendamment des symptômes et de la sévérité de l'IA) quand:

- ➔ diam. AO ascend. > 50 mm (Marfan, bicuspidie)
- ➔ diam. AO ascend. > 55 mm (maladie annulo-ectasiente)